全スタッフ向け・15 分

まちの「型」が健康を決める

歩ける・緑のあるまちは身体とこころを底上げする

参考文献

2026-08-22 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

PART 1

診察室の外に、答えがある

PART 1・診察室の外に、答えがある

「散歩しましょうね」の、その後

- 72歳男性、糖尿病、本人も「こんどこそ運動を」と前向き
- 3か月後「結局、歩いてないんです…」
- 家の前は歩道なし、車が飛ばす道
- いちばん近いスーパーまで車で15分
- → **歩きたい気持ちはある。歩ける場所がない**

PART 1・診察室の外に、答えがある

今日のゴール

- まちの「型」と健康のつながりを、ひとことで説明できる
- 「歩けない理由」を、本人の意志ではなく環境から拾える
- 自分の職種で「明日できる1つ」を決める

前回の復習: 健康は診察室の外で決まる

- 収入・住まい・つながり・食べもの ― 「社会的な要因」(SDH)
- 前回の勉強会: 生活の困りごとを聞く「スクリーニング」
- 今日はその続き: **住んでいる「まち」も要因の1つ**

  「運動不足」は本人の問題? それとも、まちの問題?

PART 2

大規模データが示した「健康なまちの型」

PART 2・大規模データが示した「健康なまちの型」

今日の研究: アメリカ2万8千地区を丸ごと分析

- MIT の都市研究チーム、Nature Health 誌（2026年7月）
- 28,323 地区の健康データ（CDC）× 街並み写真 800万枚以上
- 「どんな街並みの地区で、住民の健康がよいか」を総当たり
- 一般・身体・こころ、3つの健康を別々に見た

PART 2・大規模データが示した「健康なまちの型」

健康なまちに共通する3つの「型」



短くつながった街区

角が多く、
どこへも歩いて行ける



用途がまざる

店・診療所・学校が
住まいの近くにある



緑と公園

街路樹・公園・水辺が
すぐそこ

共通点は「歩く理由」と「歩ける道」がセットであること

PART 2・大規模データが示した「健康なまちの型」

緑は、種類によって効き方が違う

- **街路樹**（通勤・買い物で毎日通る緑）→ 全般的な健康
- **深い木立**（散歩・ハイキングができる緑）→ 身体の健康
- **公園・水辺**（座ってすごせる緑）→ こころの健康
- 問いは「緑を増やす」ではなく「**どの緑を、どこに**」

PART 2・大規模データが示した「健康なまちの型」

身体だけでなく、こころにも

- 歩けるまちほど「こころの不調」が少ない傾向
- 歩く ＝ 運動だけではない
- 人とすれ違う・立ち話をする・誰かの目がある
- → **孤立しにくいまち**が、こころを守る

  「歩く」は、社会とのつながりの入り口

PART 2・大規模データが示した「健康なまちの型」

注目: 低所得の地区ほど、行きやすさと健康の関連が大きい

- 医療機関・薬局・公園・文化施設への「行きやすさ」を改善した場合
- 行きやすさが改善したときの健康改善の推定値は、低所得地区が高所得地区の **2〜5.6倍**（論文: 100〜462%大きい）
- 差がいちばん大きいのは、こころの健康（文化施設・公園）
- → **格差を縮める手段としての「まちづくり」の手がかり**
- 実際に改善した結果ではなく、モデルによる試算

PART 2・大規模データが示した「健康なまちの型」

ただし「一緒に起きている」≠「原因」

- この研究は**ある時点の切り取り**（相関であって因果ではない）
- 逆もありうる: 体の弱い人ほど、家賃の安い＝緑の少ない地区に住む
- 著者ら自身が「因果を示すものではない」と明記
- 補強材料: 双子 7,400人を11年追った米国の研究（AJPM 2025、準因果の設計）
- → 歩きやすさが5.5単位高い地区への転居で、近所歩きが **週約15分** 増えうると推定された

PART 3

日本のわたしたちの地域では

PART 3・日本のわたしたちの地域では

日本の地方都市に置き換えると

- 車社会: スーパーも病院も「車で15分」
- 坂道・歩道なし・街灯なし ― 高齢者ほど歩けない
- 日本の高齢者 2.3万人調査(JAGES): 公園・歩道が近い地区ほど**膝痛が少ない傾向**(人口密度まで調整すると、有意なのは坂・階段がなく歩きやすい地区のみ)
- 国も動いている: 「ウォーカブル推進都市」402都市(2026年10月31日時点)
- → **うちの地域は、どの「型」?**

PART 3・日本のわたしたちの地域では

問診に1つ足す:「家のまわり、歩けますか?」

- 歩道はある? 坂はきつい? 夜は明るい?
- いちばん近い店・公園まで、歩いて何分?
- 「歩けない」の中身が変わる: 意志 → 環境
- 答えは処方箋ではなく、**紹介先と地域への材料**になる

PART 3・日本のわたしたちの地域では

職種別「明日できる1つ」

職種	明日の1つ
受付・事務	待合の掲示に「近くの公園・散歩コース地図」を1枚
看護	「散歩しましょう」の前に「家のまわり、歩けますか？」を1問
リハ	自宅周辺の坂・歩道を確認し、「歩ける経路」を一緒に決める
医師・相談員	歩けない理由が環境なら、地域包括・自治体へ1本つなぐ

PART 3・日本のわたしたちの地域では

ペアで1分:「明日の1つ」を隣に言う

1. 自分の職種の「1つ」を声に出す（30秒）
2. 相手の「1つ」を聞く（30秒）
3. できそうなら「いつやるか」も一言
4. **全体で2〜3人に発表**

ふりかえり: 3つの問い

- まちの「型」と健康のつながりを、ひとことで言うと？
- 「歩いてない」患者さんに、次は何を聞く？
- 自分の「明日の1つ」は、1か月後に何で確かめる？

まとめ

- 短くつながった街区・店の近さ・緑と公園が、身体もこころも底上げする
- 行きやすさの改善と健康の関連は、低所得地区のほうが大きい（試算で2〜5.6倍）
- ただし相関研究。因果の断定はしない
- **「歩かない患者」の前に、「歩けないまち」を見る**

参考文献

Yap W, Duarte F, Zheng Y, Jang KM, Luo P, Vineis P, Ratti C, Biljecki F. Urban motifs associated with population health. Nature Health, 2026. https://doi.org/10.1038/s44360-026-00151-9
Duncan GE, Avery AR, Pilgrim MJD, Amram O, Mooney SJ, Rundle AG. Longitudinal association between walkability and physical activity in twins. Am J Prev Med 2025;69(3):107950(PMID 40532794) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40532794/